PROTOCOLO DE TRIAGEM PSICOLÓGICA EM PSICO-ONCOLOGIA AMBULATORIAL UTILIZANDO O INDICADOR DE RISCO PSICOLÓGICO EM ONCOLOGIA (IRPO)

1. INTRODUÇÃO

O diagnóstico de câncer representa um evento potencialmente disruptivo na vida do paciente, produzindo repercussões significativas nas dimensões emocional, social e existencial. Além das demandas clínicas associadas ao tratamento oncológico, pacientes frequentemente enfrentam sentimentos de medo, incerteza quanto ao prognóstico, alterações na rotina, impacto na identidade pessoal e mudanças nas relações familiares e sociais.

Nesse contexto, a psico-oncologia destaca a importância da identificação precoce do sofrimento psicológico como parte integrante do cuidado oncológico. Estudos indicam que níveis elevados de distress emocional podem interferir negativamente na adesão ao tratamento, na comunicação com a equipe de saúde e na qualidade de vida dos pacientes.

A triagem psicológica sistemática tem sido progressivamente incorporada às práticas assistenciais em oncologia, permitindo identificar pacientes em maior vulnerabilidade psicossocial e direcionar intervenções adequadas.

A utilização de instrumentos estruturados de avaliação possibilita uma abordagem mais objetiva do sofrimento emocional, permitindo a estratificação do risco psicossocial e a organização de planos de cuidado proporcionais às necessidades identificadas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Implementar um protocolo estruturado de triagem psicológica ambulatorial para pacientes oncológicos, utilizando o Indicador de Risco Psicológico em Oncologia (IRPO) como instrumento de estratificação do risco psicossocial.

2.2 Objetivos específicos

• identificar precocemente sofrimento emocional significativo em pacientes oncológicos

• estratificar o risco psicossocial em níveis baixo, moderado ou alto

• orientar o planejamento de intervenções psicológicas proporcionais ao risco identificado

• favorecer a integração do cuidado psicológico com a equipe multiprofissional

• contribuir para a adesão ao tratamento e para a qualidade de vida dos pacientes

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Pacientes oncológicos frequentemente apresentam níveis variados de distress emocional, ansiedade, sintomas depressivos e dificuldades de adaptação ao tratamento. Estima-se que aproximadamente um terço dos pacientes com câncer apresenta sofrimento psicológico clinicamente significativo ao longo do curso da doença.

Nesse contexto, instrumentos de triagem psicológica têm sido utilizados para identificar precocemente pacientes em maior risco psicossocial e orientar intervenções adequadas.

Entre os instrumentos mais utilizados na literatura encontram-se o Distress Thermometer, a Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), o Patient Health Questionnaire (PHQ-9) e o Psychosocial Assessment Tool (PAT).

Entretanto, muitos desses instrumentos concentram-se principalmente na avaliação de sintomas emocionais específicos, como ansiedade ou depressão, não contemplando de forma abrangente os diferentes aspectos psicossociais envolvidos na experiência do adoecimento oncológico.

Dessa forma, torna-se relevante a utilização de instrumentos que avaliem de maneira integrada fatores emocionais, sociais e de enfrentamento relacionados ao processo de adoecimento.

4. JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DO IRPO

O Indicador de Risco Psicológico em Oncologia (IRPO) foi escolhido como instrumento central deste protocolo por apresentar características particularmente adequadas ao contexto da psico-oncologia.

O instrumento foi desenvolvido especificamente para o contexto oncológico, contemplando dimensões psicossociais diretamente relacionadas à experiência do câncer.

Diferentemente de instrumentos focados apenas em sintomas psicopatológicos, o IRPO avalia múltiplos domínios relevantes para a adaptação à doença, incluindo percepção da enfermidade, suporte social, estratégias de enfrentamento e nível atual de distress.

Outro aspecto relevante refere-se à sua capacidade de estratificação do risco psicossocial, permitindo classificar pacientes em diferentes níveis de vulnerabilidade psicológica.

Essa característica favorece a organização do cuidado psicológico de forma proporcional às necessidades identificadas, possibilitando direcionar recursos assistenciais de maneira mais eficiente.

Além disso, o IRPO apresenta aplicabilidade adequada ao contexto ambulatorial, com tempo de aplicação reduzido e interpretação relativamente simples, facilitando sua utilização na rotina assistencial.

A validação do instrumento no contexto brasileiro também contribui para sua pertinência cultural e clínica.

Dessa forma, a utilização do IRPO possibilita integrar triagem psicológica estruturada, estratificação de risco e planejamento de intervenções psicológicas no contexto da assistência oncológica.

5. INDICADOR DE RISCO PSICOLÓGICO EM ONCOLOGIA (IRPO)

O IRPO é um instrumento destinado à avaliação de fatores psicossociais relevantes no contexto do adoecimento oncológico.

Entre os domínios avaliados encontram-se:

• percepção da doença
• suporte social emocional
• suporte social instrumental
• estratégias de enfrentamento (coping)
• nível atual de distress

A soma dos escores gera o Índice Global de Risco (IGR).

Classificação do risco:

Baixo risco: IGR < 55
Risco moderado: IGR entre 55 e 69
Alto risco: IGR ≥ 70

Essa classificação orienta o planejamento das intervenções psicológicas.

6. FLUXO OPERACIONAL DA TRIAGEM

1 Triagem inicial multiprofissional
2 Aplicação do IRPO
3 Cálculo do Índice Global de Risco (IGR)
4 Classificação do risco psicossocial
5 Verificação de indicadores de alerta clínico
6 Definição do plano de cuidado psicológico
7 Integração com a equipe multiprofissional
8 Monitoramento e reavaliação

7. INDICADORES DE ALERTA CLÍNICO

A presença de determinados sinais clínicos pode indicar maior vulnerabilidade psicológica e necessidade de intervenção prioritária.

Entre os principais indicadores de alerta encontram-se:

- ☐ **• ideação suicida ativa**
- ☐ **• pensamentos de autoagressão**
- ☐ **• desesperança intensa**
- ☐ **• ansiedade grave ou crises de pânico**
- ☐ **• sintomas depressivos graves**
- ☐ **• isolamento social significativo**
- ☐ **• recusa persistente de tratamento**
- ☐ **• conflitos familiares intensos relacionados ao diagnóstico/tratamneto**
- ☐ **• sofrimento existencial significativo**
- ☐ **• vulnerabilidade social relevante**
- ☐ **• sobrecarga importante do cuidador**

Na presença desses indicadores recomenda-se priorizar avaliação psicológica e considerar discussão multiprofissional e avaliação psiquiátrica.

8. INTEGRAÇÃO MULTIPROFISSIONAL

O cuidado psicológico no contexto oncológico deve ocorrer em articulação com os demais profissionais da equipe de saúde, incluindo médicos, enfermagem, serviço social e cuidados paliativos.

Essa integração favorece uma abordagem mais abrangente das necessidades do paciente e contribui para o planejamento compartilhado do cuidado.

9. REAVALIAÇÃO

Pacientes classificados como risco moderado ou alto devem ser reavaliados periodicamente para monitoramento da evolução emocional e necessidade de ajustes no plano de cuidado psicológico.

10. Tabela – Estratificação de risco psicológico e intervenções

Nível de risco: BAIXO

Faixa IGR: <55
Características: coping adaptativo, distress leve, rede de apoio adequada
Intervenções: psicoeducação e orientações psicológicas breves
Sessões: 1 sessão com monitoramento
Integração: suporte geral da equipe
Mini-caso: paciente com boa adaptação ao tratamento

Nível de risco: MODERADO

Faixa IGR: 55–69
Características: distress moderado, coping inconsistentes
Intervenções: psicoterapia breve focada em enfrentamento
Sessões: 3–4 sessões quinzenais
Integração: articulação multiprofissional
Mini-caso: paciente com ansiedade moderada

Nível de risco: ALTO

Faixa IGR: ≥70
Características: distress intenso, coping deficitário
Intervenções: psicoterapia intensiva e possível avaliação psiquiátrica
Sessões: 6–8 sessões inicialmente semanais
Integração: integração multiprofissional prioritária
Mini-caso: paciente com desesperança e isolamento

11. FLUXOGRAMA DA TRIAGEM

Paciente em atendimento ambulatorial
↓
Triagem multiprofissional
↓
Aplicação do IRPO
↓

Cálculo do IGR
↓
Classificação do risco psicológico
↓
Verificação de indicadores de alerta
↓
Definição do plano de cuidado psicológico
↓
Monitoramento e reavaliação

12. MODELO DE REGISTRO EM PRONTUÁRIO

Hospital Universitário de Brasília – HUB/EBSERH

Unidade Ambulatorial de Oncologia – UNACON

IRPO (Indicador de Risco Psicológico em Oncologia)

Triagem psicológica

Identificação do (a) paciente:

Diagnóstico oncológico:

Data :

Fase do tratamento

( ) diagnóstico

( ) tratamento ativo

( ) recidiva / progressão

( ) cuidados paliativos

( ) seguimento

Instrumento aplicado

( ) IRPO

IGR: _____

Classificação do risco

( ) baixo

( ) moderado

( ) alto

Indicadores de alerta

( ) não identificados

( ) identificados – especificar: _____

Plano de cuidado psicológico

( ) psicoeducação e orientações psicológicas breves (1 sessão)

( ) psicoterapia breve (3–4 sessões quinzenais)

( ) psicoterapia intensiva (6–8 sessões inicialmente semanais)

( ) inclusão de familiares no acompanhamento

( ) discussão do caso com equipe multiprofissional

( ) encaminhamento para avaliação psiquiátrica

( ) encaminhamento para outro serviço de saúde mental

Conduta definida

( ) realizada psicoeducação e orientação psicológica breve em sessão única

( ) iniciado acompanhamento psicológico breve

( ) iniciado acompanhamento psicológico intensivo

( ) encaminhamento para avaliação psiquiátrica

( ) discussão multiprofissional

( ) outra conduta: _____

Reavaliação prevista

( ) em 2 semanas
( ) em 30 dias
( ) após 3 sessões

( ) na próxima consulta oncológica

( ) conforme evolução clínica

( ) outra: _____

Observações clínicas adicionais

_____

13. REFERÊNCIAS

BULTZ, B. D.; CARLSON, L. E. Emotional distress: the sixth vital sign in cancer care. Journal of Clinical Oncology, 2006.

BRUERA, E. et al. The Edmonton Symptom Assessment System. Journal of Palliative Care, 1991.

CARLSON, L. E.; BULTZ, B. D. Efficacy of psychosocial interventions in cancer care. Psycho-Oncology, 2003.

FALLER, H. et al. Effects of psychooncologic interventions on emotional distress and quality of life in adult patients with cancer. Journal of Clinical Oncology, 2013.

OSBORN, R. L. et al. Psychosocial interventions for depression, anxiety and quality of life in cancer survivors. Psycho-Oncology, 2006.

ZIGMOND, A.; SNAITH, R. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1983.

KROENKE, K. et al. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine, 2001.

HUI, D.; BRUERA, E. Integrating palliative care into oncology care. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2016.

KAZAK, A. et al. The psychosocial assessment tool. Journal of Pediatric Psychology, 2001.

SOUZA, J. R. S. Validação do Indicador de Risco Psicológico em Oncologia (IRPO). Universidade de Brasília, 2014.